

Epilepsia

1. Introducción y relevancia clínica

La **epilepsia** es un **trastorno cerebral crónico** caracterizado por la **tendencia a presentar crisis epilépticas recurrentes** (≥ 2 crisis no provocadas separadas por más de 24 horas), como resultado de **descargas eléctricas anormales, excesivas o sincronizadas de las neuronas corticales**.

Es una de las patologías neurológicas crónicas más comunes en pediatría: afecta a **4–10 por 1.000 niños**.

Su manejo adecuado evita deterioro cognitivo, accidentes y estigmatización, y mejora la calidad de vida.

El **EUNACOM** suele evaluar:

- Diagnóstico diferencial entre **convulsión febril y epilepsia**.
 - Clasificación de crisis según la **ILAE (focal, generalizada, desconocida)**.
 - **Fármacos de elección** por tipo de crisis y sus efectos adversos.
 - **Conducta inicial** ante primera crisis afebril.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La epilepsia se produce por una **alteración del equilibrio entre la excitación (glutamato) y la inhibición (GABA) neuronal**.

Este desequilibrio genera **hiperexcitabilidad y sincronización neuronal anormal**, lo que se traduce en una **descarga paroxística cortical**.

Causas

- **Genéticas (idiopáticas)**: canalopatías, síndromes familiares.
- **Estructurales/metabólicas**: malformaciones corticales, displasia, trauma, tumores, infecciones, hipoxia perinatal.

- **Inmunológicas o infecciosas:** encefalitis, neurocisticercosis, VIH.
- **Desconocidas (criptogénicas):** sin causa demostrable.

3. Clasificación de crisis epilépticas (ILAE 2023)

Tipo principal	Subtipo	Manifestaciones clínicas	Ejemplo
Focal (parcial)	- Con conciencia preservada - Con alteración de conciencia	Movimientos o sensaciones localizadas, automatismos	Crisis temporal, Jacksoniana
Generalizada	- Tónico-clónica - Ausencia - Mioclónica - Atónica	Pérdida de conciencia inmediata, movimientos bilaterales o caída súbita	Gran mal, ausencia infantil
De origen desconocido	—	Crisis no clasificable por información insuficiente	Crisis neonatal ambigua
Síndromes epilépticos específicos	—	Conjunto característico de edad, tipo de crisis y hallazgos EEG	Lennox-Gastaut, West, Rolándica

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Crisis focales

- Pueden comenzar con **aura sensorial o motora**.
- Movimientos localizados, desviación ocular o cefálica.

- Posible **automatismo** (lamido, manipulación).
- Conciencia conservada o alterada según extensión.

b.

Crisis generalizadas

- **Tónico-clónicas (gran mal):** rigidez → sacudidas → sueño posictal.
- **Ausencias (petit mal):** detención súbita de la actividad, mirada fija, sin caída.
- **Mioclónicas:** sacudidas breves de extremidades.
- **Atónicas:** pérdida brusca del tono y caída.

c.

Síndromes epilépticos pediátricos clásicos

Síndrome	Edad	Tipo de crisis	Pronóstico
Epilepsia Rolándica benigna	5–12 años	Focales orofaríngeas, nocturnas	Excelente, remite en adolescencia
Ausencias infantiles (petit mal)	4–10 años	Ausencias breves múltiples/día	Bueno con etosuximida/valproato
Síndrome de West (espasmos infantiles)	<1 año	Espasmos en flexión, regresión del desarrollo	Grave
Lennox-Gastaut	2–8 años	Variadas, refractarias	Malo, con déficit cognitivo

5. Exámenes complementarios y diagnóstico

a.

Electroencefalograma (EEG)

- Prueba clave: identifica **actividad epileptiforme paroxística**.
- Debe realizarse **después del primer episodio afebril** si sospecha clínica.
- EEG normal **no excluye epilepsia** (solo positivo en ~50–70 %).

b.

Neuroimagen

- **RM cerebral** preferida.
- Indicada si:
 - Crisis focal.
 - Déficit neurológico persistente.
 - Refractariedad al tratamiento.
 - Sospecha estructural (tumor, displasia, malformación).

c.

Exámenes complementarios selectivos

- Electrolitos, glicemia, Ca^{2+} , Mg^{2+} , fósforo (crisis nuevas).
- Punción lumbar si sospecha de infección.
- Estudios genéticos/metabólicos según contexto.

6. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIFE / ILAE)

a.

Principios generales

1. Confirmar diagnóstico antes de iniciar tratamiento.
2. Monoterapia: iniciar con un solo fármaco a dosis baja.
3. Ajustar dosis según respuesta y efectos adversos.
4. Evaluar suspensión tras 2 años sin crisis y EEG normal.

b.

Fármacos de primera elección según tipo de crisis

Tipo de crisis	Fármaco de elección	Alternativas
Focal	Carbamazepina	Oxcarbazepina, levetiracetam
Tónico-clónica generalizada	Valproato de sodio	Levetiracetam, lamotrigina
Ausencias	Etosuximida	Valproato
Mioclónicas	Valproato	Levetiracetam
Atónicas / Lennox-Gastaut	Valproato + benzodiazepinas	Topiramato, lamotrigina
Espasmos infantiles (West)	ACTH o vigabatrina	Corticoides

☐ **Valproato es el fármaco de elección más amplio** (excepto en adolescentes mujeres por riesgo teratogénico).

c.

Efectos adversos relevantes

Fármaco	Efectos adversos frecuentes
Valproato	Aumento de peso, hepatotoxicidad, trombocitopenia
Carbamazepina	Somnolencia, hiponatremia, reacciones cutáneas
Lamotrigina	Rash, riesgo de Stevens-Johnson
Levetiracetam	Irritabilidad, alteraciones conductuales
Etosuximida	Trastornos gastrointestinales

d.

Tratamiento de urgencia (estatus epiléptico)

1. **Benzodiazepina:** diazepam 0,3 mg/kg EV o midazolam 0,2 mg/kg intranasal.
 2. Si persiste: **fenitoína 15–20 mg/kg EV** o **levetiracetam 40 mg/kg EV**.
 3. Si no responde → **anestesia con midazolam o fenobarbital**.
-

7. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- Traumatismos durante la crisis.
- Estatus epiléptico.

- **Efectos adversos de fármacos.**
- **Alteraciones cognitivas y psicosociales** en epilepsias refractarias.

b. Pronóstico

70–80 % de los niños logran **control completo de crisis** con monoterapia.

Epilepsias benignas (Rolándica, ausencias) remiten espontáneamente.

Epilepsias sintomáticas estructurales tienen peor evolución.

8. Seguimiento y educación

- Cumplir tratamiento sin suspender bruscamente.
 - Evitar privación de sueño, alcohol o fármacos que bajen umbral convulsivo.
 - Control neurológico regular y monitoreo de efectos adversos.
 - Educación a la familia y colegio sobre **manejo de crisis**.
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. **Epilepsia = ≥ 2 crisis no provocadas separadas >24 h.**
2. **EEG** es el examen confirmatorio, **RM** busca causas estructurales.
3. **Valproato** es el antiepiléptico de elección en crisis generalizadas.
4. **Carbamazepina** es de elección en crisis focales.
5. **Ausencias:** mejor tratamiento con **etosuximida**.
6. **Suspender anticonvulsivante tras 2 años sin crisis + EEG normal.**
7. **Estatus epiléptico:** diazepam IV como primera línea.

☐ **Errores frecuentes:**

- Diagnosticar epilepsia tras una sola crisis.
 - Tratar crisis febril simple con anticonvulsivantes.
 - Usar carbamazepina en crisis de ausencia (puede empeorarla).
 - No hacer RM en epilepsia focal.
 - Suspender bruscamente medicación → riesgo de estatus epiléptico.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Epilepsia:** ≥ 2 crisis no provocadas separadas >24 h.
2. Clasificación: **focal, generalizada, desconocida.**
3. **EEG y RM** son esenciales para diagnóstico y etiología.
4. **Valproato:** crisis generalizadas; **carbamazepina:** focales.
5. **Etosuximida:** ausencias.
6. Control completo en 70–80 % con monoterapia.
7. Suspender tratamiento tras 2 años sin crisis y EEG normal.